

Intieme problemen bij mannen met diabetes

Dr. J. Van Dyck
Uroloog

UZ Leuven – Campus Gasthuisberg

Seksuele dysfunctie en diabetes

- Erectiestoornissen
- Verminderd libido
- Ejaculatiestoornissen
- Uitblijven van een orgasme

Isidro, 2011

Erectiestoornissen

Komen erectiestoornissen vaak voor?

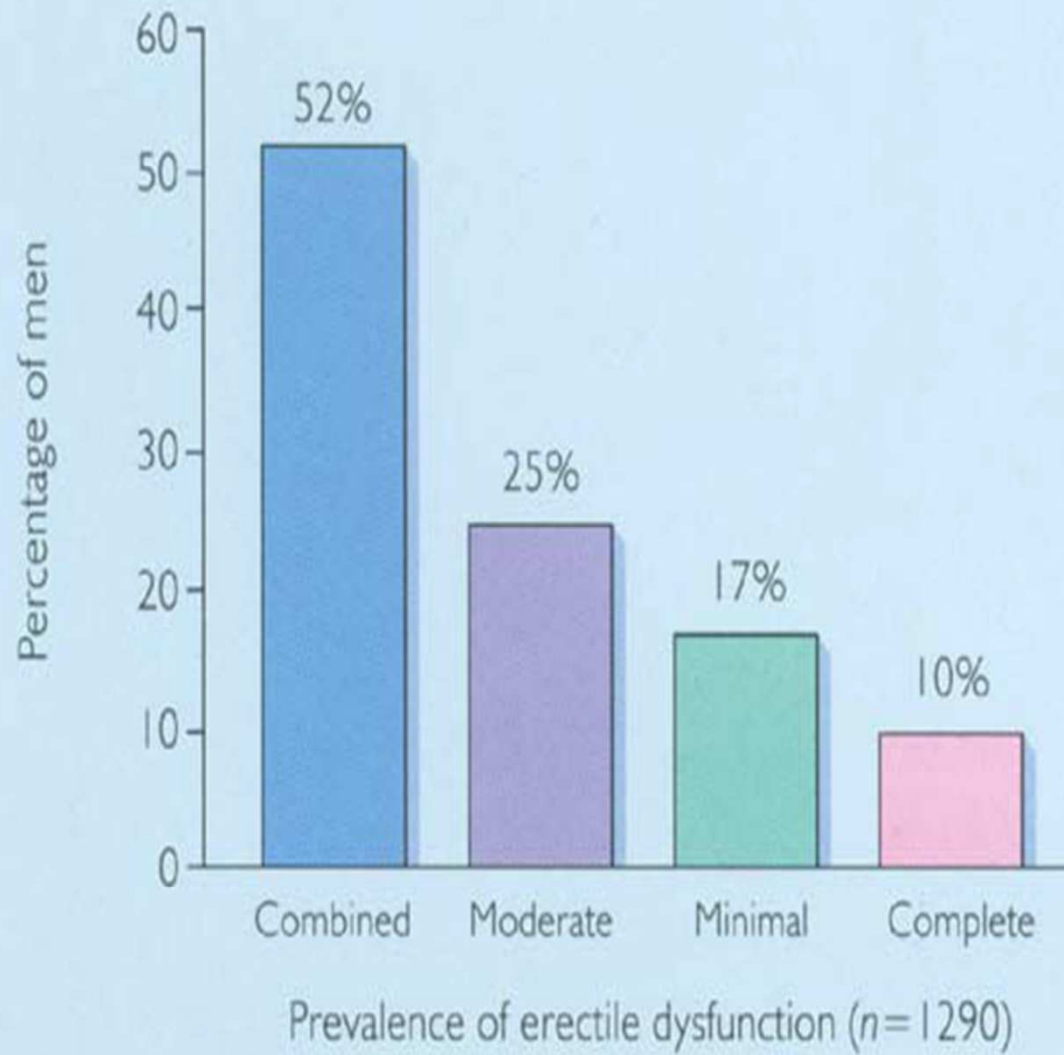


Erectiestoornissen

- MMAS:
 - Mannen 40-70 jaar: 52 %
 - Minimale erectiestoornissen: 17.2%
 - Matige erectiestoornissen: 25.2%
 - Ernstige erectiestoornissen 9.6 %

Derby, 2001

Voorkomen van erectiestoornissen



Derby, 2001

Erectiestoornissen

- Cologne studie:
 - Mannen 30-80 jaar
 - Erectiestoornissen 19.2%
 - Variatie leeftijdsafhankelijk: 2.3% -> 53%

Braun, 2000

Erectiestoornissen

- Aantal nieuwe gevallen /1000 inwoners per jaar:
 - Nederland: 19.2/1000/jaar
 - Brazilië: 65.6/1000/jaar

Wespes, 2010

Erectiestoornissen

- Aantal nieuwe gevallen /1000 inwoners per jaar:
 - Nederland: 19.2/1000/jaar
 - Brazilië: 65.6/1000/jaar





oornissen

000 inwoners per jaar:



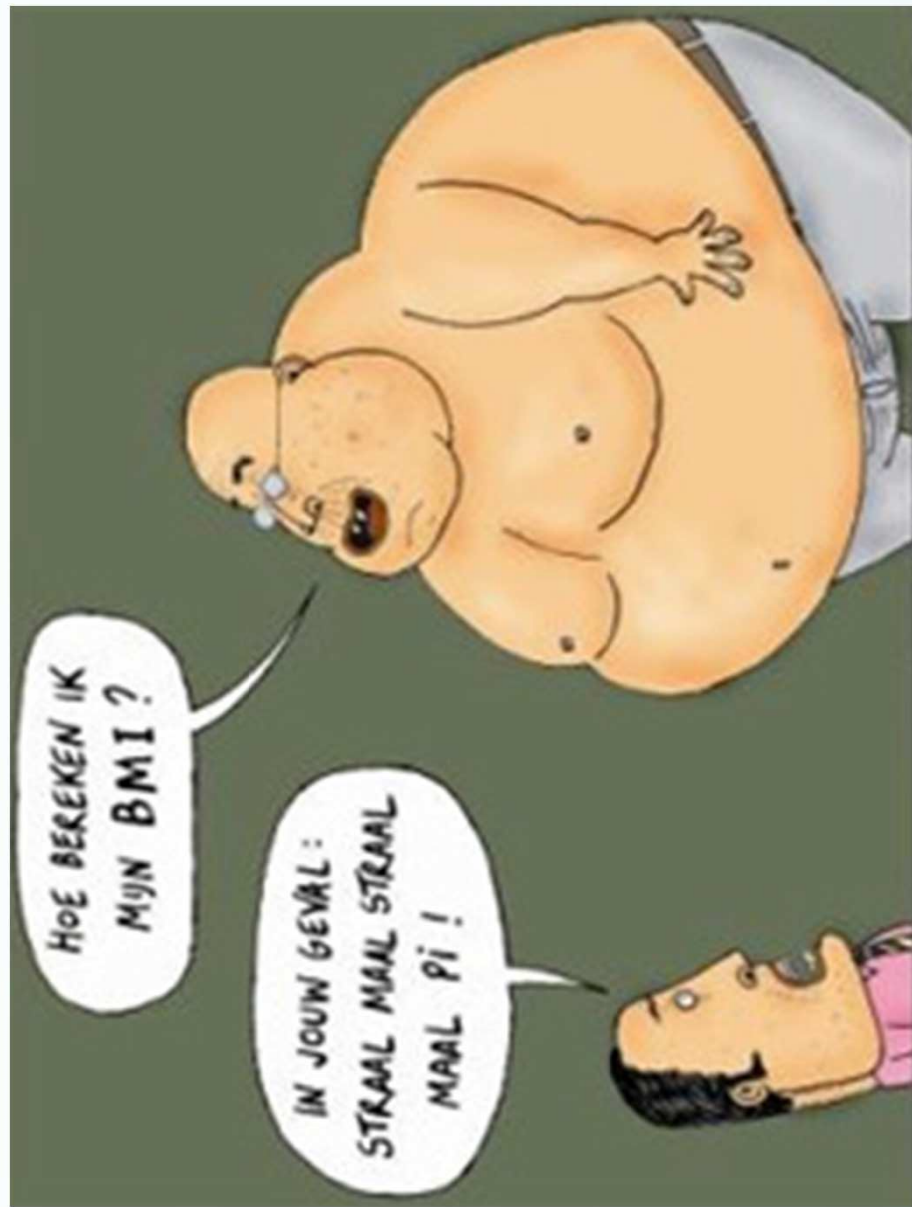
ED en diabetes

- 35-75 % diabetici hebben erectiestoornissen
 - +60 jaar: 55-95 %
- Erectiestoornissen ontstaan 5-10 jaar eerder bij diabetici dan bij niet-diabetici

Fonseca, 2005

Risicofactoren ED

- Cardiovasculaire risicofactoren
 - Zwaarlijvigheid
 - Sedentaire levensstijl
 - Roken
 - Hoge cholesterol
 - Metabool syndroom
- Operatie voor prostaatkanker



Erectiestoornissen

- Risico omkeerbaar?
- MMAS:
 - Man, middelbare leeftijd, start beweging
 - 70 % risico reductie

Derby, 2001





Oorzaken ED

Vasculogenic• Cardiovascular disease• Hypertension• Diabetes mellitus• Hyperlipidaemia• Smoking• Major surgery (radical prostatectomy) or radiotherapy (pelvis or retroperitoneum)NeurogenicCentral causes• Multiple sclerosis• Multiple atrophy• Parkinson's disease• Tumours• Stroke• Disk disease• Spinal cord disordersPeripheral causes• Diabetes mellitus• Alcoholism• Uraemia• Polyneuropathy• Surgery (pelvis or retroperitoneum, radical prostatectomy)Anatomical or structural• Peyronie's disease• Penile fracture• Congenital curvature of the penis• Micropenis• Hypospadias, epispadiasHormonal• Hypogonadism• Hyperprolactinemia• Hyper- and hypo-thyroidism• Cushing's diseaseDrug-induced• Antihypertensives (diuretics and beta-blockers are the most common causes)• Antidepressants• Antipsychotics• Antiandrogens• Antihistamines• Recreational drugs (heroin, cocaine, methadone)Psychogenic• Generalized type (e.g. lack of arousability and disorders of sexual intimacy)• Situational type (e.g. partner-related, performance-related issues or due to distress)

Oorzaken ED

- Bloedvaten
- Zenuwbundels
- Anatomische afwijkingen
- Hormoonafwijkingen
- Psychologische factoren

Oorzaken ED: bloedvaten

- Hoge bloeddruk
- Hart en vaatziekten
- **Diabetes**
- Roken
- Hoge cholesterol
- Grote operaties onderbuik
- Radiotherapie onderbuik

Oorzaken ED: zenuwbundels

- Multiple sclerose, MSA
- Parkinson
- CVA/beroerte
- Ruggenmergtrauma
- **Diabetes**
- Alcoholisme
- Nierfunctiestoornissen

Oorzaken ED: andere

- Anatomische aandoeningen:
 - Kromstand
 - Penisbreuk
 - Aangeboren afwijkingen
- Hormonale afwijkingen:
 - Hypofyse
 - Hypothalamus
 - Bijnieren
 - Diabetes geïnduceerd hypogonadisme
- Psychogeen

Oorzaken ED: medicijnen

- Medicijnen tegen hoge bloeddruk
 - Betablokkers, diuretica (plaspillen) -> vaak bij **diabetici**
- Antidepressiva
- Antipsychotica
- Anti-androgenen
- Drugs (marihuana, heroïne, cocaïne,...)

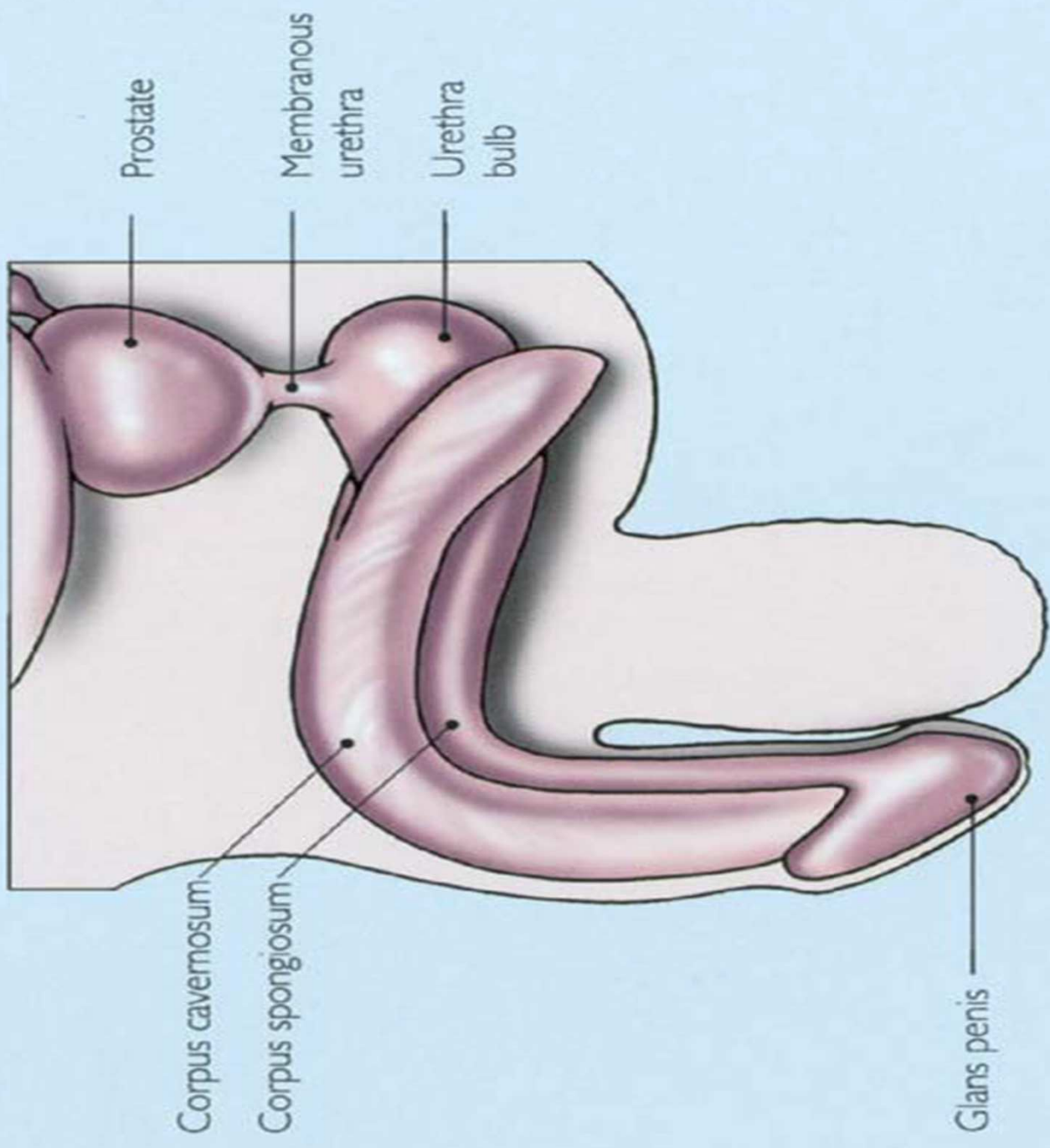
Erectiestoornissen

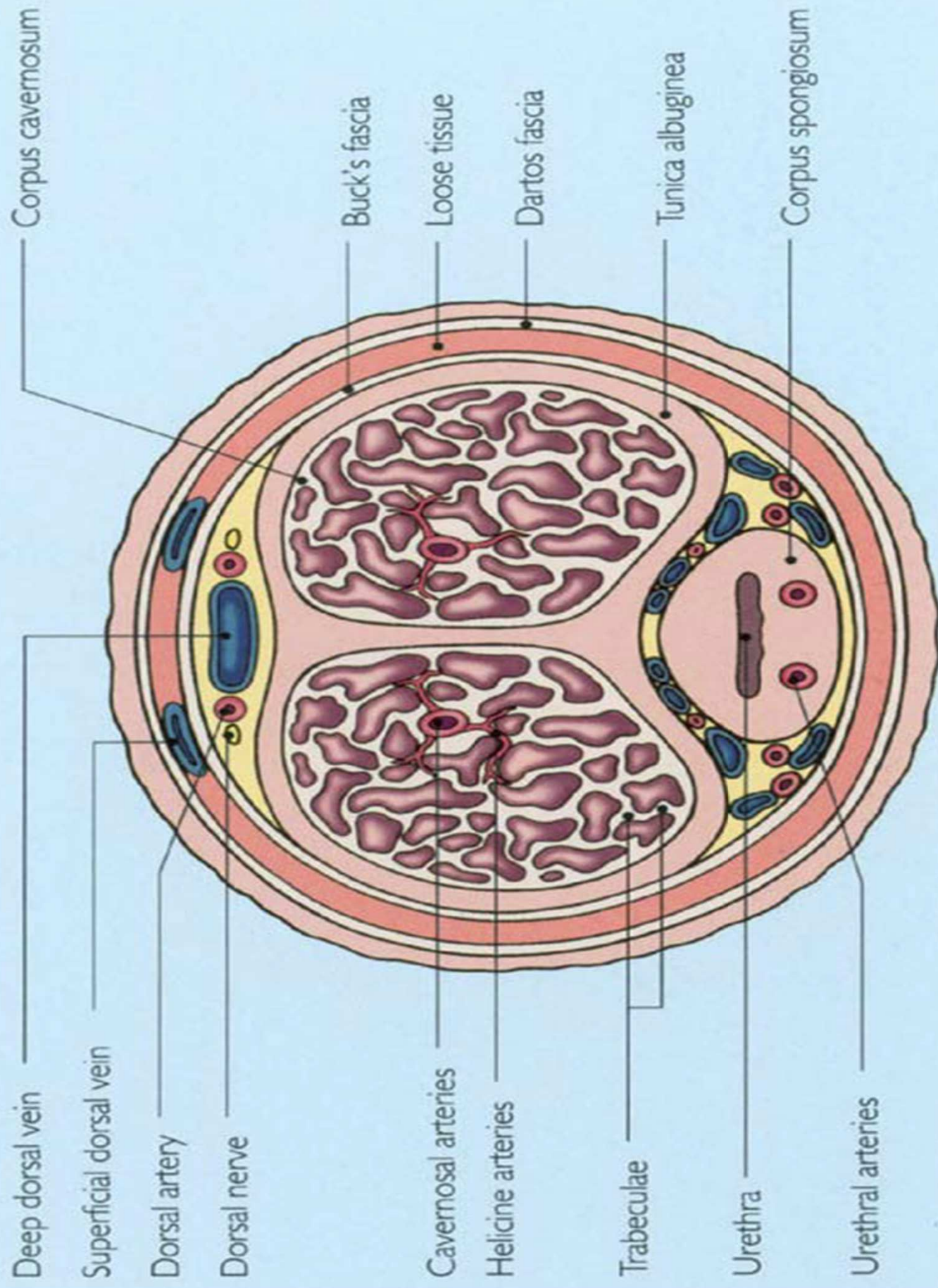
- Hoe ontstaat een erectie?

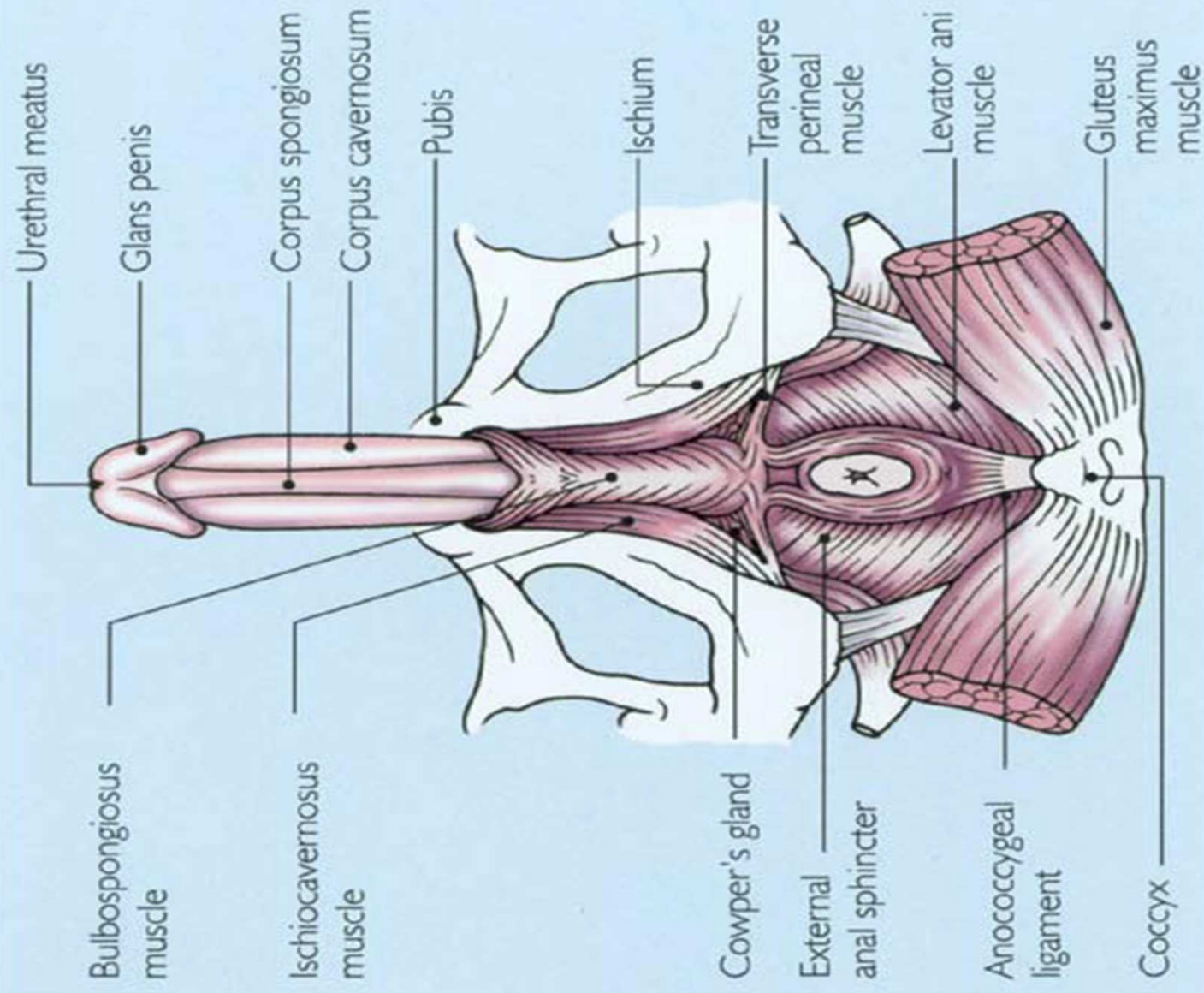
Erectiestoornissen

- Hoe ontstaat een erectie?





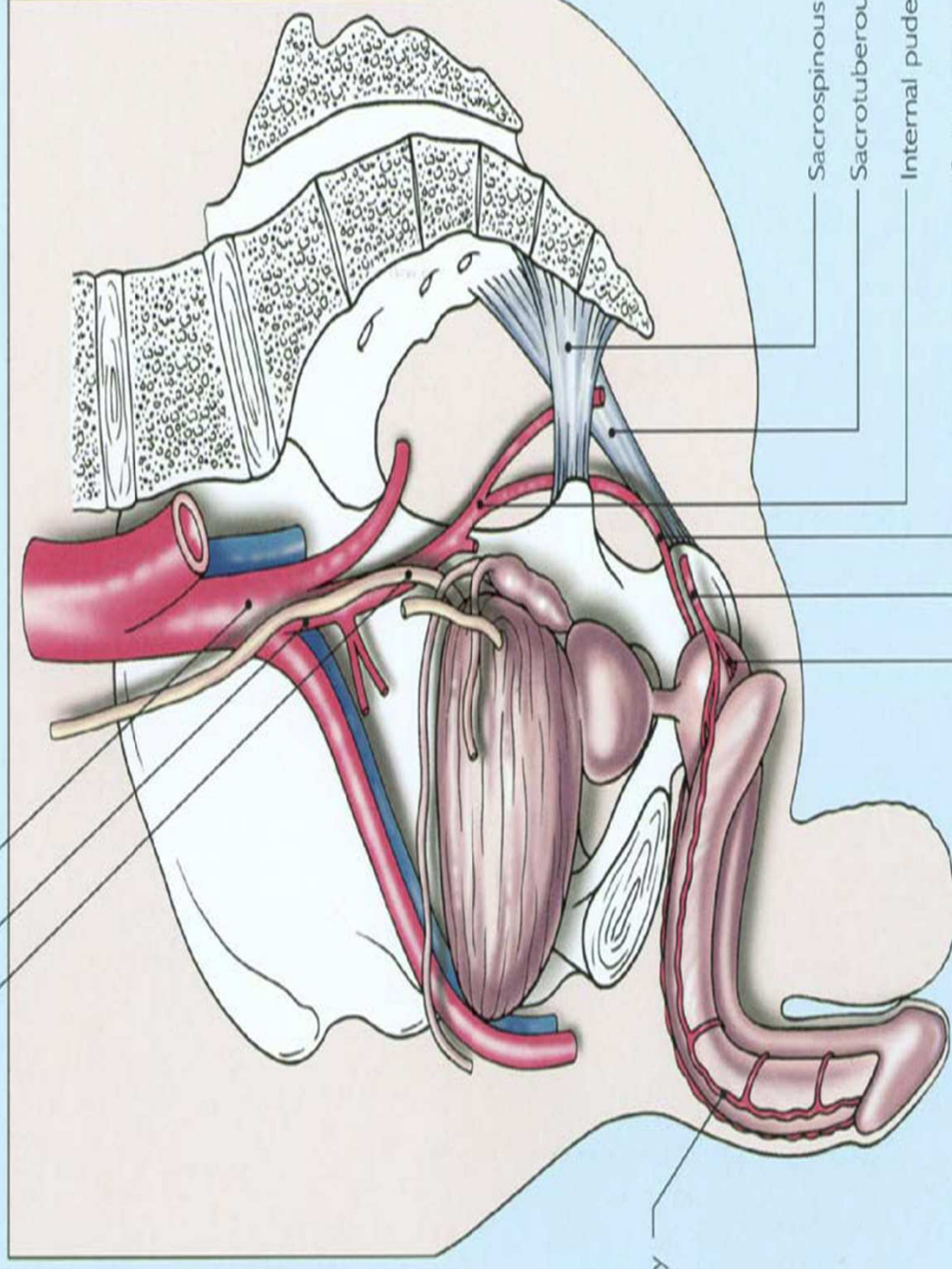




Common iliac artery

Internal iliac artery

Ureter



Dorsal artery

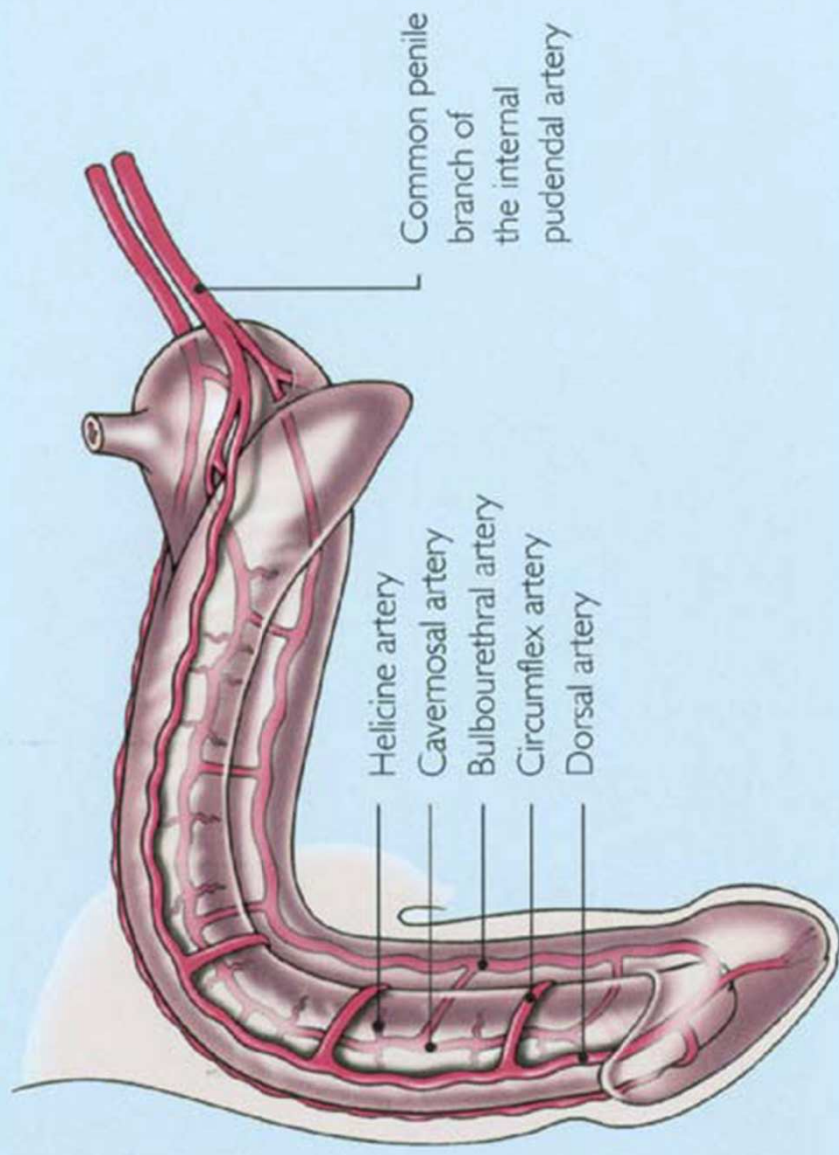
Sacrospinous ligament

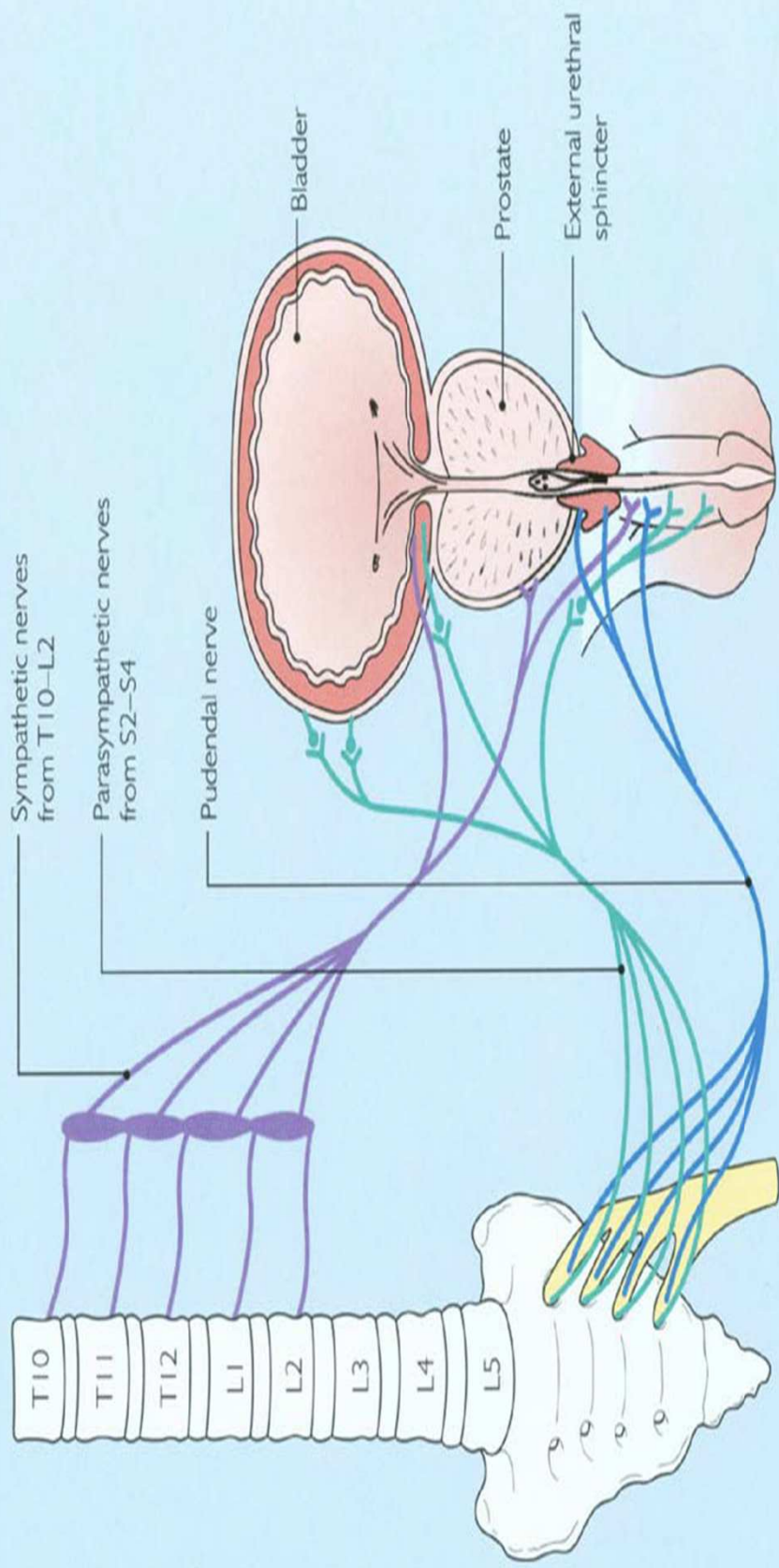
Sacrospinous ligament

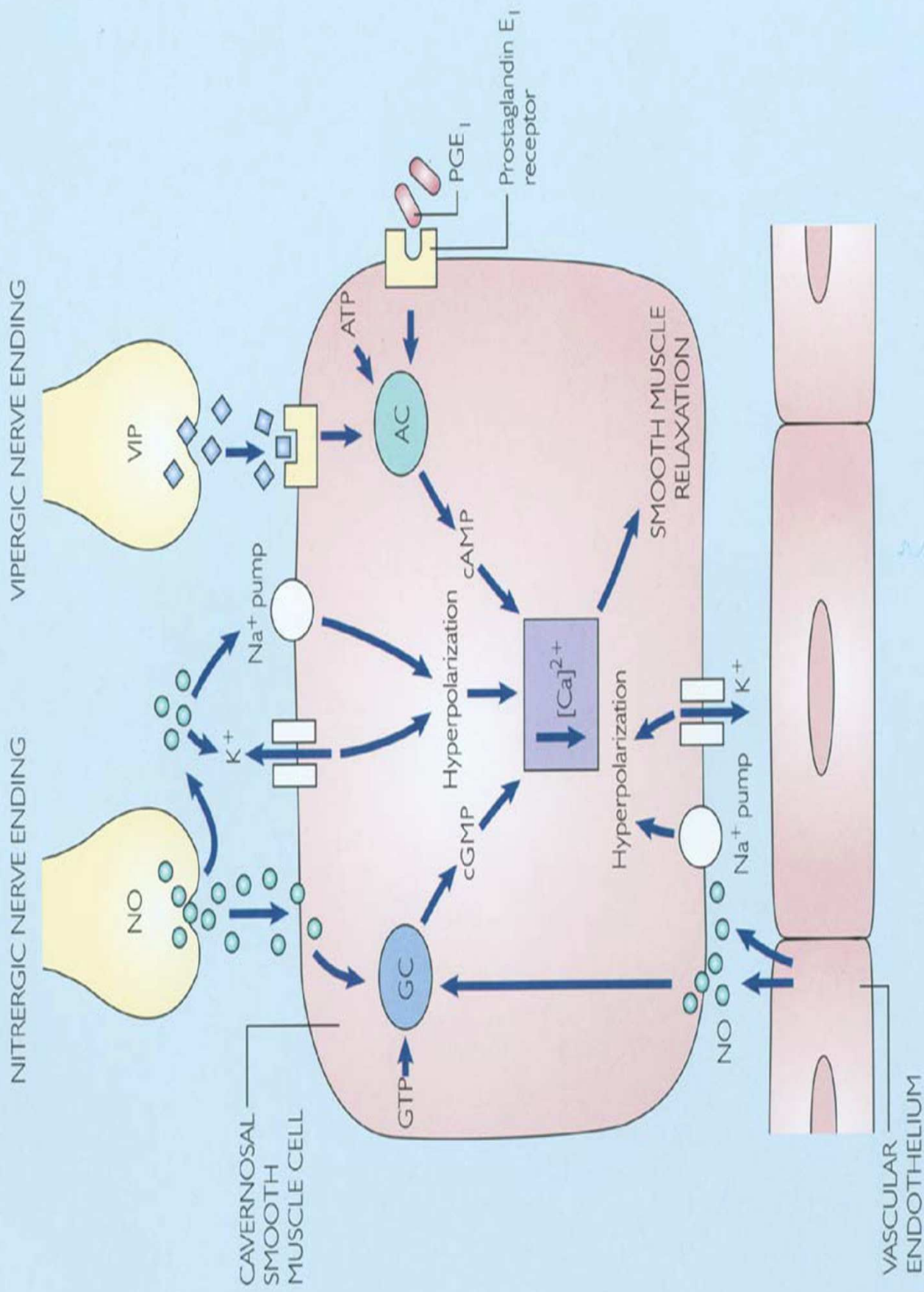
Internal pudendal arteries

Common penile artery

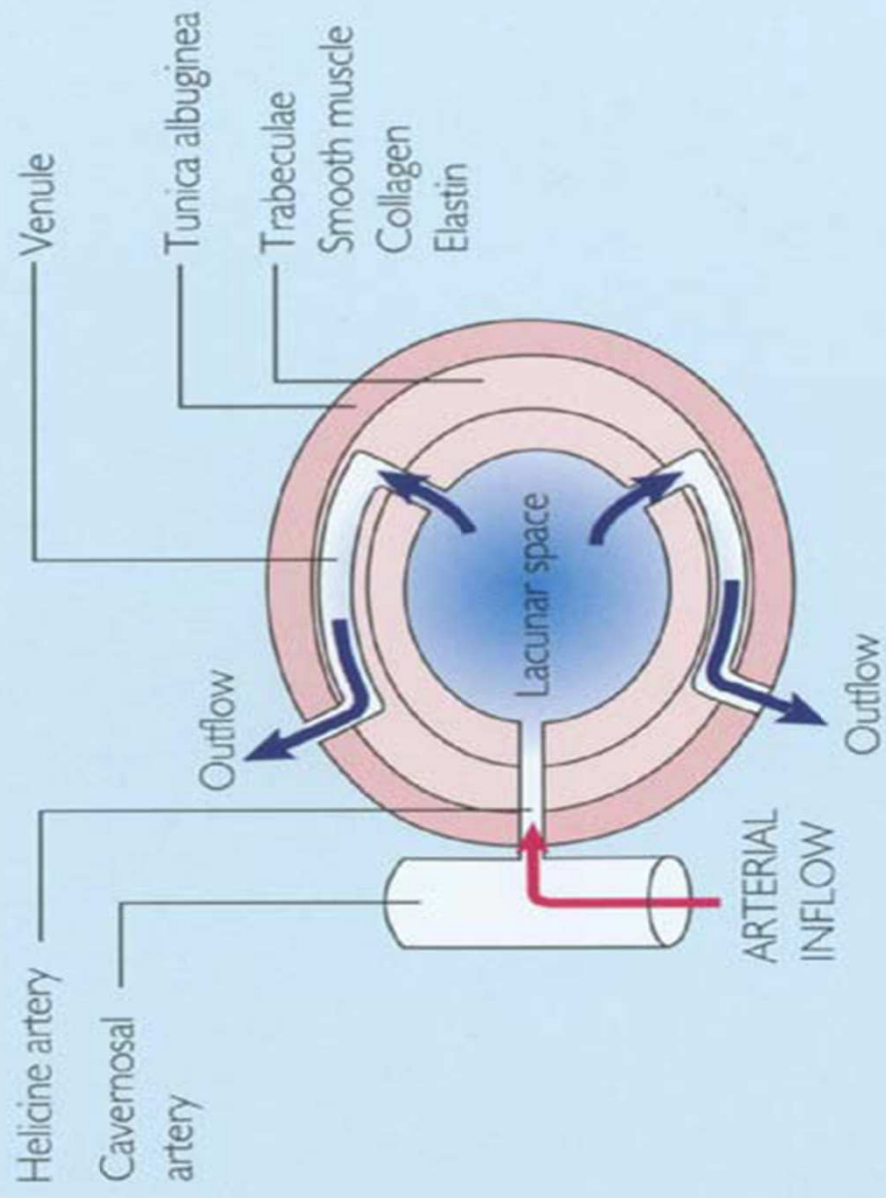
Cavernosal artery



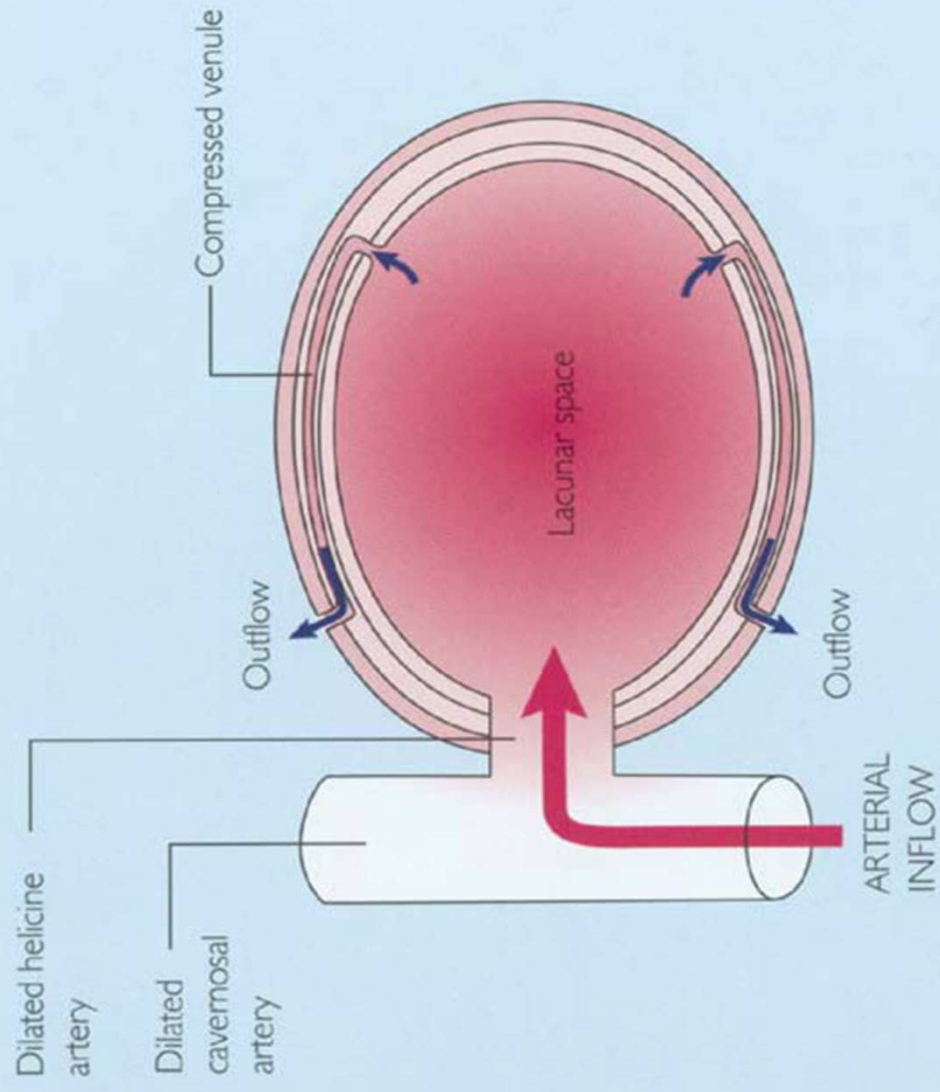




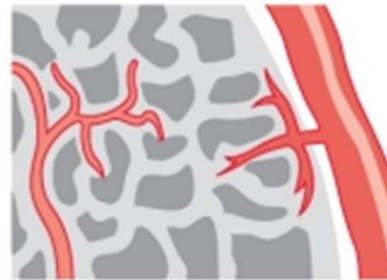
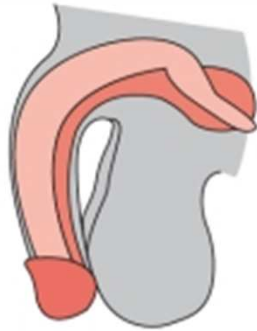
FLACCID STATE



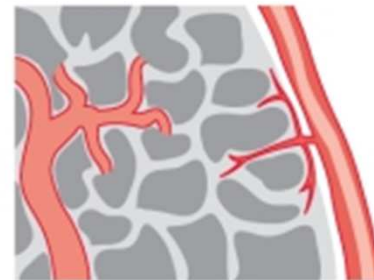
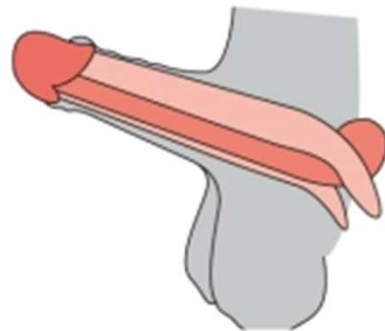
ERECT STATE



Mechanisme erectie



Bloed kan door de ader wegstromen. Penis is slap.



Bloed kan niet meer wegstromen. Penis is stijf.

Erectiestoornissen bij diabetes

- Hoge bloedsuikers veroorzaken een versuikering van de elastische vezels van de zwellichamen
- Stoornissen in de vethuishouding
- Endotheeldysfunctie
- Perifere vaatziekten: minder input in de zwellichamen
- Eindproducten suiker storen NO mechanisme
- Diabetische neuropathie: gestoorde zenuweinden
- Hypogonadotroof hypogonadisme
- Medicamenteus

Erectiestoornissen bij diabetes

790

SEXUAL FUNCTION IN MEN WITH DIABETES TYPE 2

TABLE 2. *Erectile function score stratified by categories of glycemic control*

	Mean Score $\pm$ 1 SD				
	21.5 $\pm$ 2.4	18.4 $\pm$ 5.3	16.3 $\pm$ 6.6	16.0 $\pm$ 5.2	13.4 $\pm$ 5.9
No. subjects	10	17	15	16	20
Mean subject age $\pm$ 1 SD	65.3 $\pm$ 11.3	65.6 $\pm$ 11.9	67.7 $\pm$ 8.1	57.4 $\pm$ 13.2	56.9 $\pm$ 12.6
% Hemoglobin A1c	6.0 or Greater	6.1–7.0	7.1–8.0	8.1–9.0	Greater than 9.0
% Peripheral neuropathy	30	27	60	88	90

Romeo, 2000

Behandeling erectiestoornissen

- Hoe worden erectiestoornissen behandeld?

Behandeling erectiestoornissen

- Hoe worden erectiestoornissen behandeld?



Behandeling erectiestoornissen

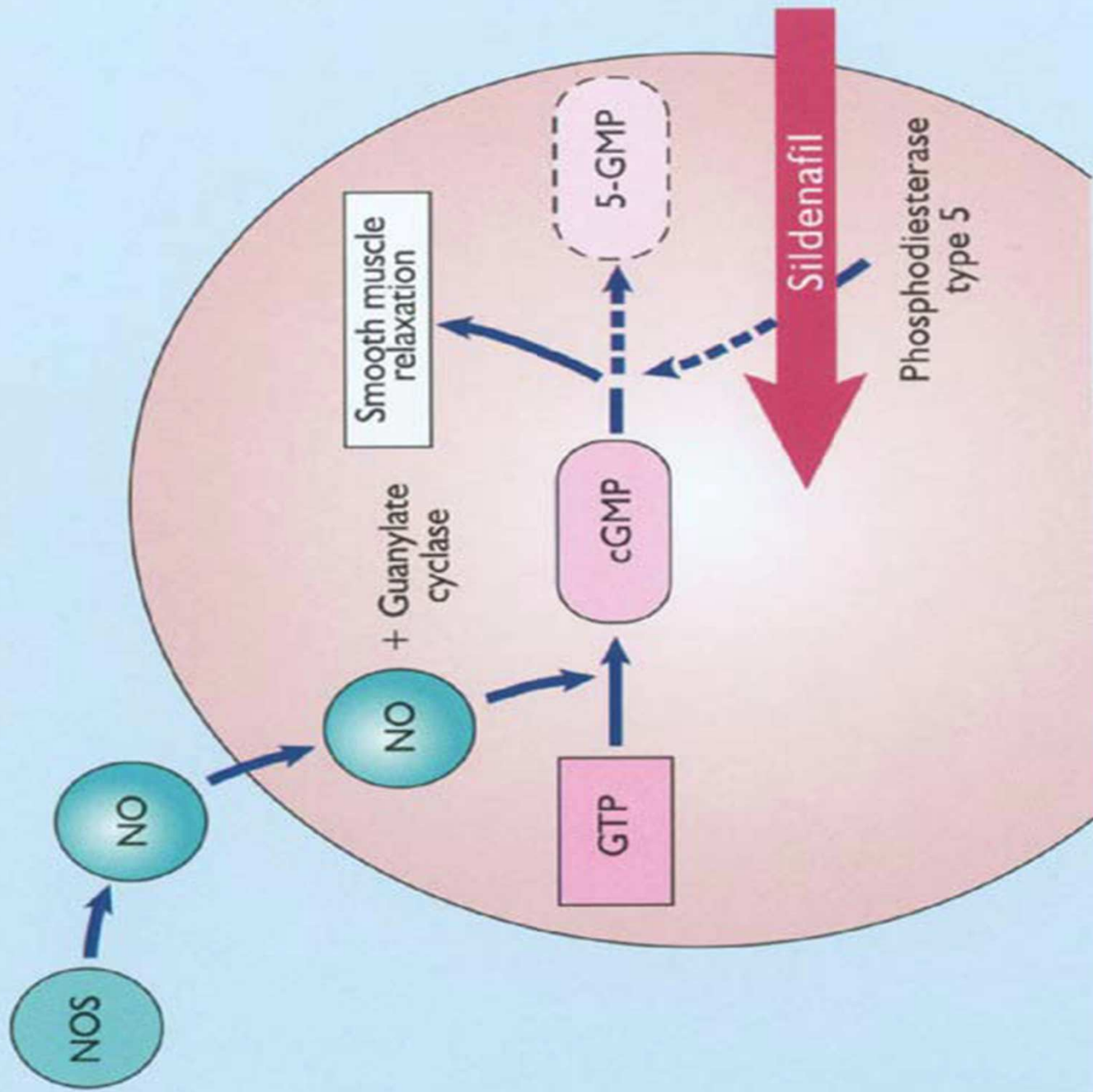
- Aanpassing levenswijze
- Verlagen van de BMI door gezonde voeding en levensstijl aanpassingen
- Meer lichaamsbeweging
- Goede controle van de bloedsuikerwaarden en vethuishouding

Behandeling erectiestoornissen

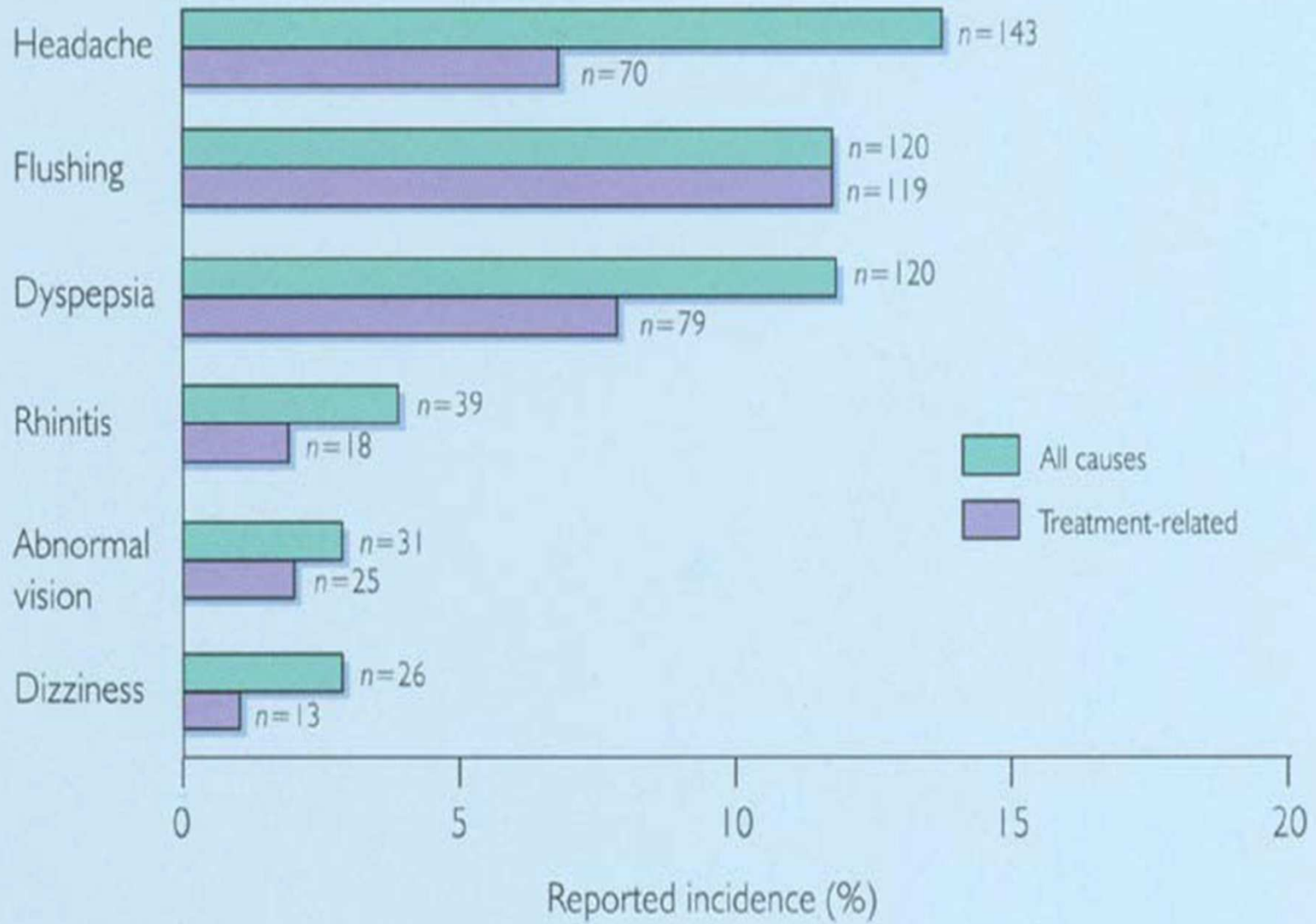
- Levenswijze aanpassen
- Medicatie:
 - Oraal gebruik
 - Injecties in de zwellichamen
- Vacuumpomp
- Chirurgie
 - Erectieprothese

ED: medicijnen

- PDE5-I:
 - Sildenafil (Viagra[®])
 - Vardenafil (Levitra[®])
 - Tadalafil (Cialis[®])
- Mag niet ingenomen worden samen met nitraten (Cedocard[®], Nitroligual[®], Nitroderm[®], Minitran[®], Diatrusor[®], Deponit[®], Trinipatch[®])



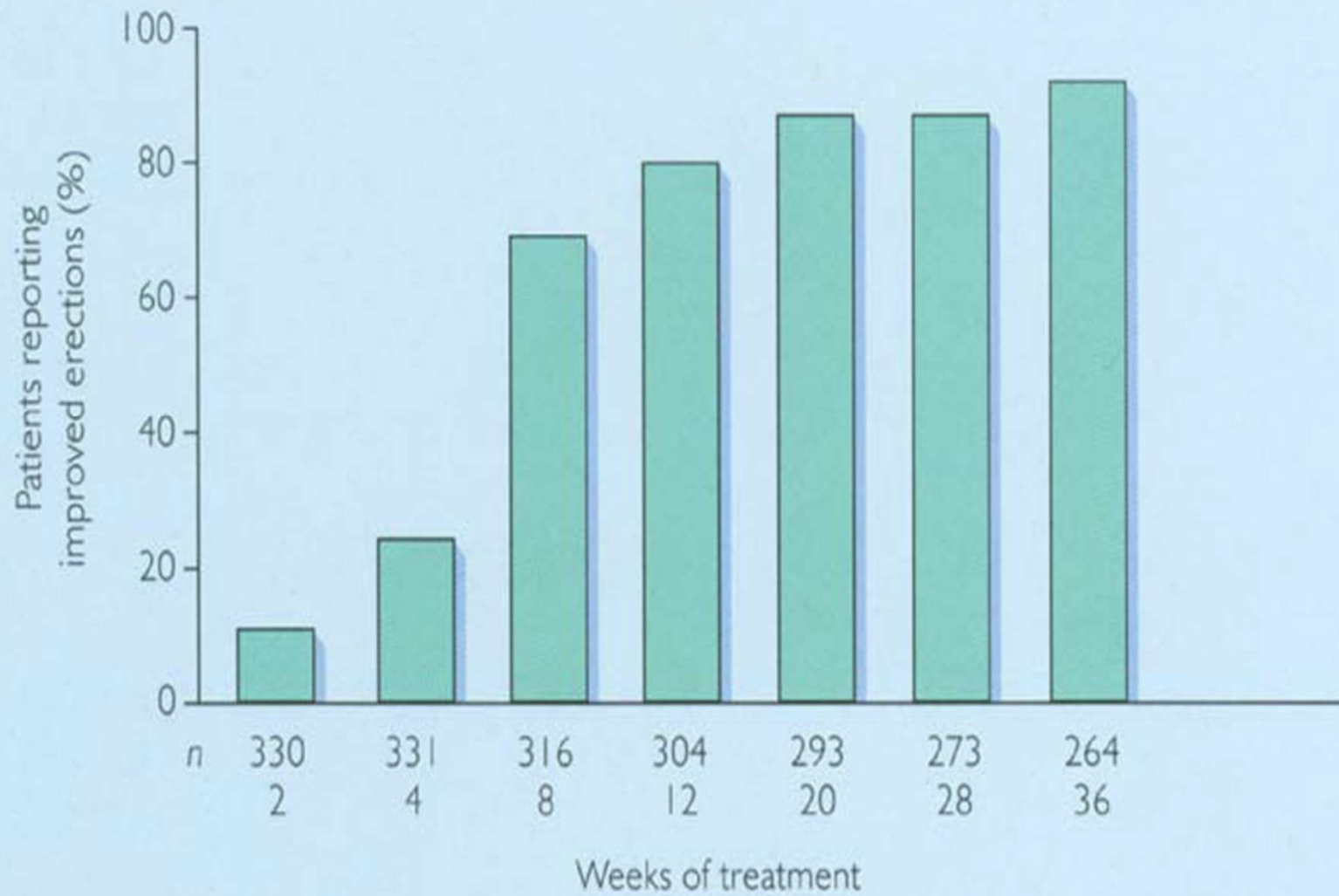
Neveneffecten PDE5I



Steers, 2001

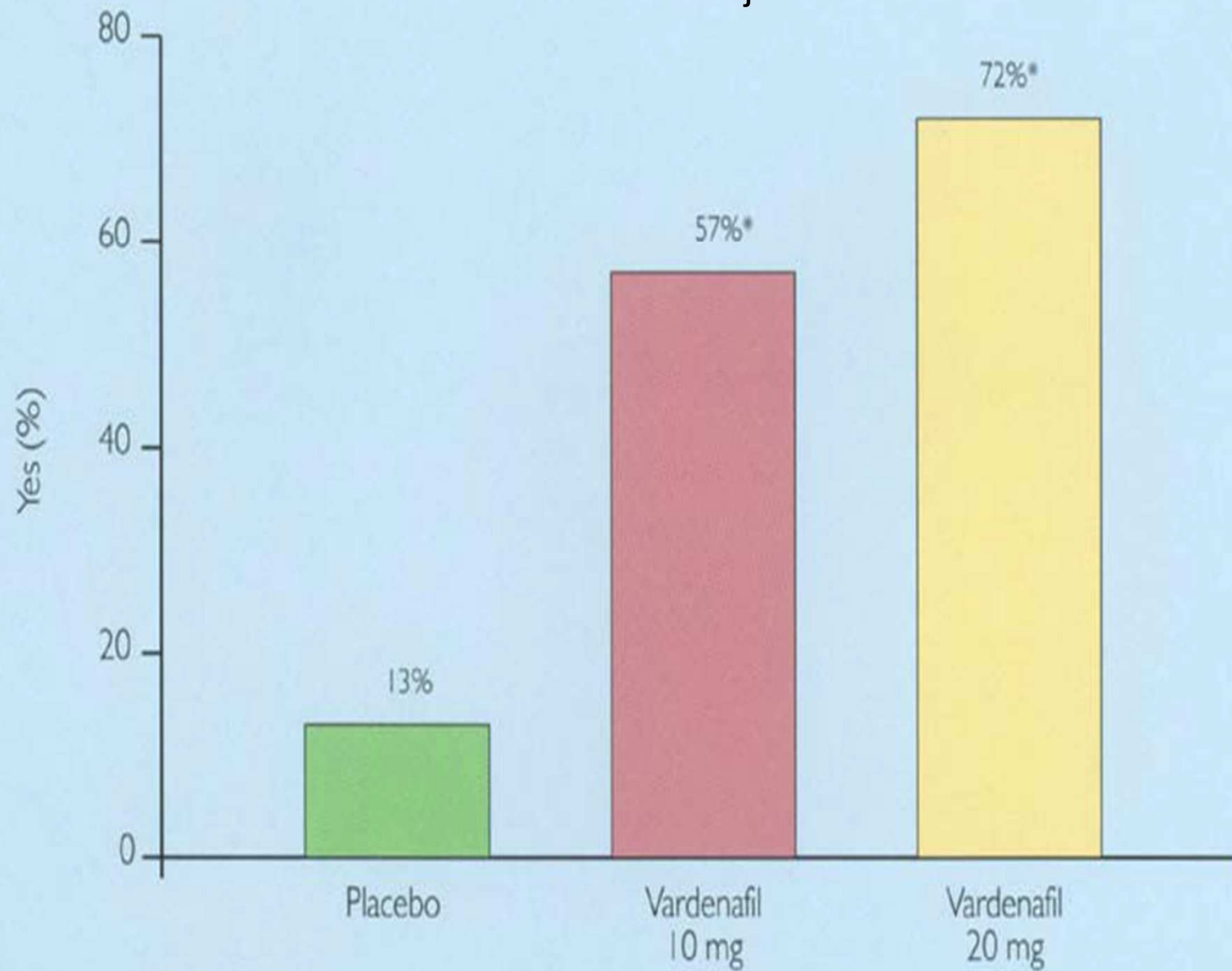
Cialis	Levitra	Viagra
Onset of action 20–60 minutes Length of action 24–36 hours Efficacy 70–80% Points to consider Meals do not affect absorption	Onset of action 20–60 minutes Length of action 5 hours Efficacy 70–80% Points to consider A fatty meal may affect absorption	Onset of action 20–60 minutes Length of action 4–6 hours Efficacy 70–80% Points to consider Recent and heavy meals may slow absorption

Verbetering erecties na start PDE5I



Steers, 2001

% tevredenheid van PDE5I bij diabetici met ED

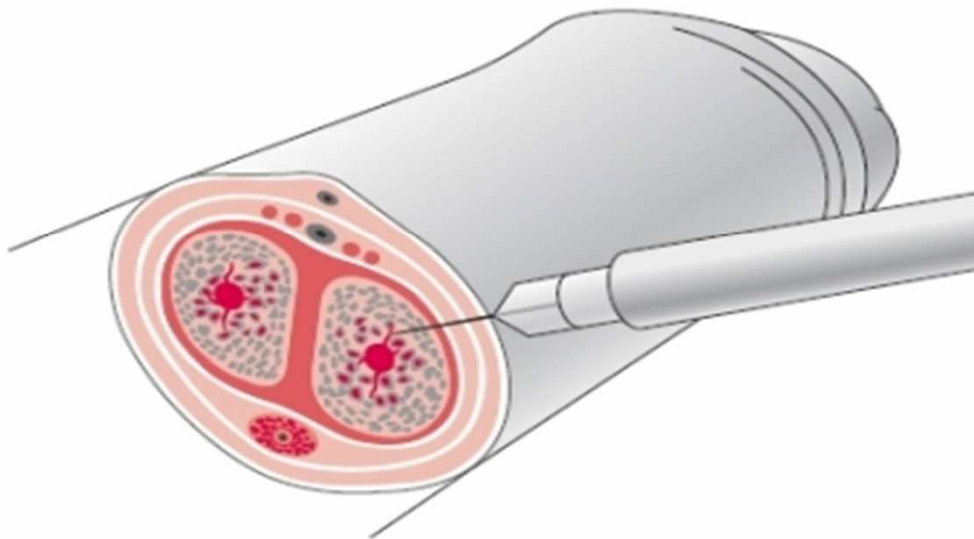


* $p < 0.0001$ vs. placebo

Goldstein, 2001

ED: medicijnen

- Intracavernosale injecties (zelf toe te dienen)
 - Papaverine
 - Phentolamine
 - Prostaglandine E1 – Alprostadyl (Caverject®)



ED: medicijnen

- Intracavernosale injecties. Neveneffecten:
 - Priapisme
 - Bloeduitstorting
 - Littekenvorming

ED: medicijnen

- Prijzen van medicamenteuse behandeling van erectiestoornissen:
 - Viagra: 38-49 euro per 4 comprimés
 - Caverject: 58-81 euro per 5 injecties

ED: medicijnen

- Prijzen van medicamenteuse behandeling van erectiestoornissen:
 - Viagra: 38-49 euro per 4 comprimés
 - Caverject: 58-81 euro per 5 injecties

IS HET DAT WEL WAARD ????



ED: medicijnen

- Prijzen van medicamenteuse behandeling van erectiestoornissen:
 - Viagra: 38-49 euro per 4 comprimés
 - Caverject: 58-81 euro per 5 injecties

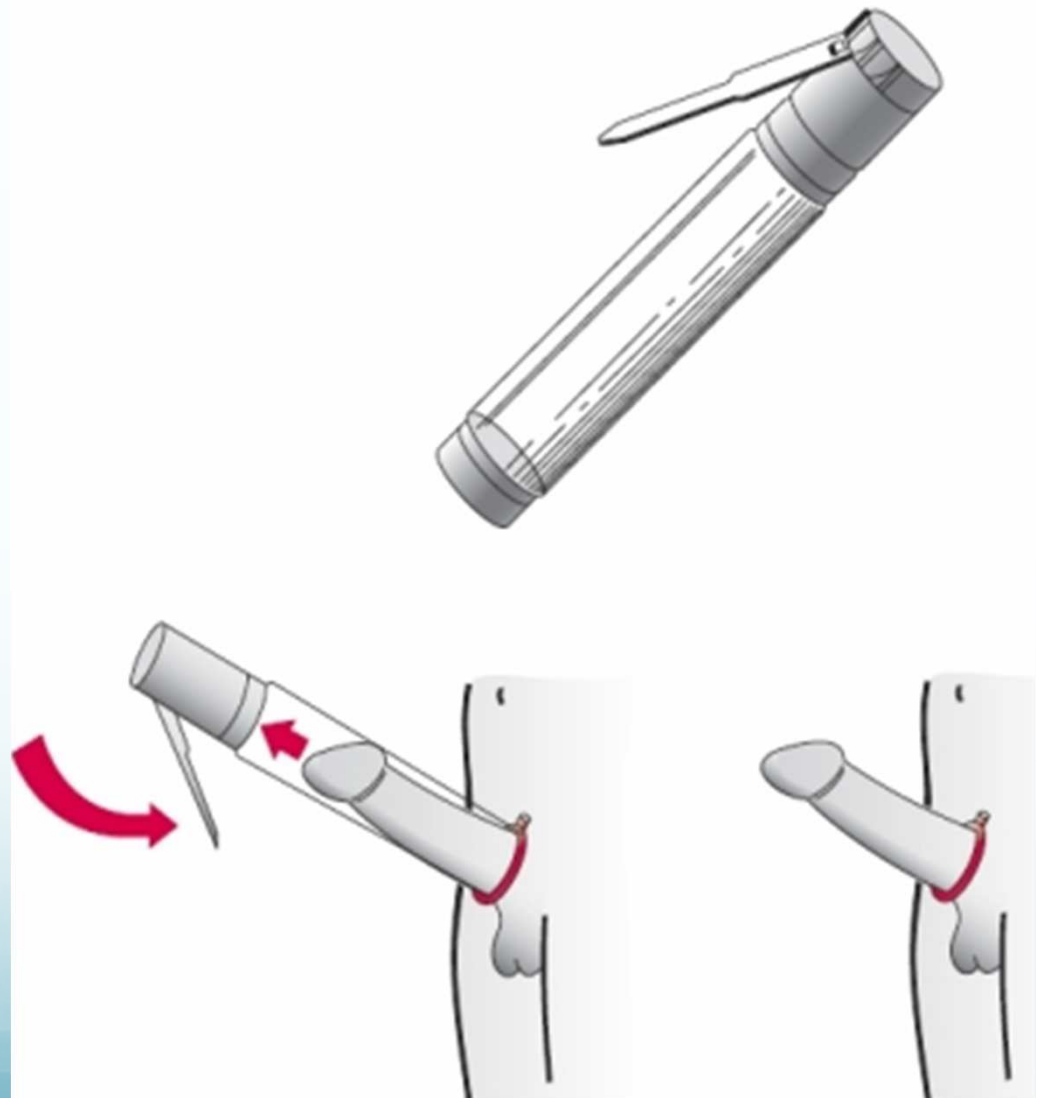
MAAR:

- Sildenafil generisch: 7-15 euro per 4 comprimés !!!



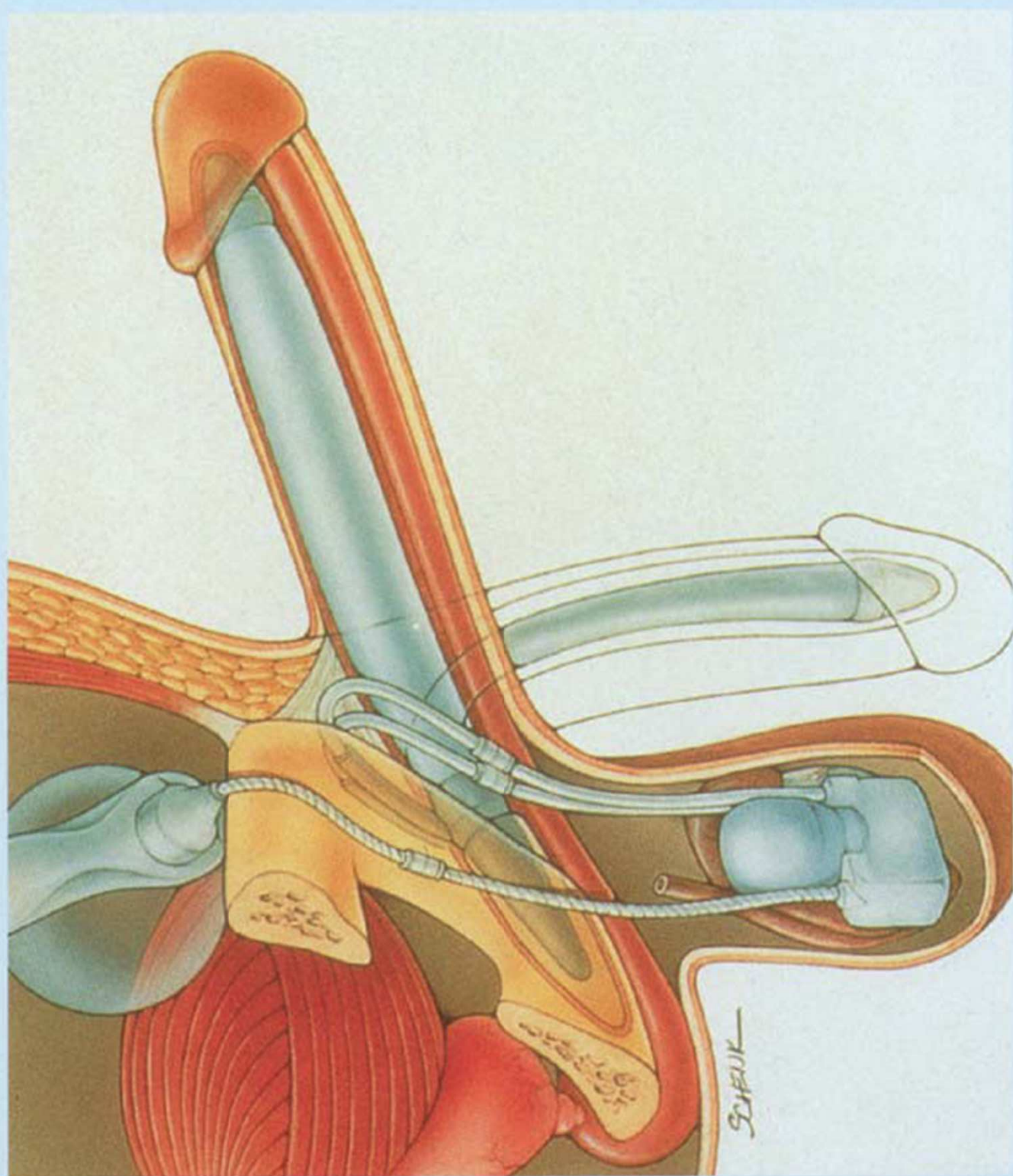
Vacuumpomp

- Vacuumpomp
met afsluitende ring
rond de basis van
de penis



Erectieprothese

- Definitieve maar onomkeerbare oplossing
- Klein risico op infectie
- Kans op revisiechirurgie
- +/-5000 euro waarvan +/-4000 euro terugbetaald
- Alleen door experts! (Hasselt, Luik, ...)



Diabetes en seksualiteit bij de vrouw

- Gerapporteerde problemen
 - Vermoeidheid
 - Veranderingen in perimenstruele bloedsuikerwaarden
 - Vaginitis (het niet kunnen ontspannen van vaginale spieren)
 - Dispareunie (pijn bij het vrijen)
 - Verminderd libido en verminderde opwinding
 - Verminderde vaginale vochtigheid
 - Moeilijk of niet meer kunnen bereiken van een orgasme

Behandeling

- Aanpak van onderliggende psychologische factoren (depressie)
- Behandeling van onderliggend probleem pijnlijk vrijen
 - Postmenopauzale verandering van het slijmvlies en de lubricatie van de vagina
 - Vaginaal glijmiddel (hormonen bevattende creme's enkel iom gynecoloog)
 - Bekkenbodemonkinétherapie (relaxatie)

Take home messages

- Seksuele dysfunctie bij diabetes meer dan erectiestoornissen alleen
- Oorzaak erectiestoornissen bij diabetici multifactorieel
- Sterke link met hart-en vaataandoeningen
- Aanpassen levenswijze is belangrijk en efficiënt
- Praat erover met uw huisarts en laat u zo nodig verwijzen naar een specialist
- Zeer hoog succespercentage indien gepaste therapie

